

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA SÍNDROME GRIPAL E SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE

Versão 2.0 - 2026



**Prefeitura de
Joinville**

SAÚDE



MISSÃO

"Promover saúde e bem-estar para as pessoas."



VISÃO

"Ser uma instituição ágil e inovadora, atenta as necessidades de integralidade e sustentabilidade, referência em gestão de saúde pública no Brasil."

VALORES



Orgulho e Paixão

Transparência

Empatia e Cuidado

Eficiência e Inovação

Sustentabilidade e Governança



PREFEITA

Rejane Gambin

SECRETÁRIA DA SAÚDE

Daniela Aparecida Gregório França Cavalcante

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Jocelita Cardozo Colagrande

DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Vanessa Cardoso Pacheco

DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Aline Gabrielle de Souza Berkenbrock

DIRETORIA DE GESTÃO JURÍDICA E ORGANIZACIONAL

Marcianita Lopata de Lima

DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Amanda Nunes

DIRETORIA TÉCNICA

Luana Garcia Ferrabone

DIRETORIA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE

Sheila Batista de Araújo

DIRETORIA DE VIGILÂNCIAS

Maria Cristina Antunes Willemann

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Jaqueline Fornari

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Maria Guilhermina Murtinho de Borba

GERÊNCIA DE INSUMOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Anderson Viebranz

GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATÓRIO MUNICIPAL

Johnattan Curcio

GERÊNCIA DE DISTRITO SANITÁRIO

Bruna Daniela Dumont Ladeira Landmann – Distrito Leste

Grasiela Florencio Medeiros - Distrito Norte

Gislaine Batista de Souza - Distrito Sul

Maristela Mello de Aguiar - Distrito Oeste

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Gabriela Neves Buch



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE

GERÊNCIA DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Juliana Antunes Safanelli

GERÊNCIA DE REGULAÇÃO

Flaviane Andrzejewski

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Liziana Lúcio Ardigó

GERÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ARTICULAÇÃO HOSPITALAR

Nádia Cristina Brach

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA QUALIDADE E PROCESSOS

Cibely Schipitoski Borges

ELABORAÇÃO/COLABORAÇÃO

Carolina Rodrigues Miranda

Adriana Bitencourt Magagnin

Vanessa de Souza Fernandes Bernardino

REVISÃO/FORMATAÇÃO

Thais Camile Bauer de Oliveira



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	6
2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA.....	8
2.1. DEFINIÇÃO DE CASO.....	8
3. JUSTIFICATIVA.....	14
4. ESTRATÉGIAS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA.....	15
5.CONCLUSÕES.....	21
REFERÊNCIAS.....	22
Fluxograma 01. “Atendimento ao Usuário com Síndrome Gripal (SG) na Atenção Primária à Saúde (APS) no Município de Joinville”.....	24
Fluxograma 02 “Atendimento ao Usuário com Síndrome Gripal (SG) nas Unidades de Urgência e Emergência (UUE) do Município de Joinville”.....	26
Anexo 01. Infográfico “Cuidados para Evitar Doenças Respiratórias”.....	28



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

APS: Atenção Primária à Saúde
GEDIM: Gerência de Doenças Infecciosas Agudas e Imunização
HMSJ: Hospital Municipal São José
LACEN/SC: Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina
mg: Miligramas
MS: Ministério da Saúde
NGQP: Núcleo de Gestão de Qualidade e Processos
NMV/r: Associação dos fármacos antivirais nirmatrelvir e ritonavir
O₂: Oxigênio
OVR: Outros Vírus Respiratórios
PA: Pronto Atendimento
PSE: Programa Saúde na Escola
SARS-CoV-2: Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2
SE: Semana Epidemiológica
SECOM: Secretaria de Comunicação
SES: Secretaria Executiva da Saúde / Secretaria da Saúde
SES.UVI / SES.UVS: Unidades ou Diretorias vinculadas à Secretaria da Saúde
SG: Síndrome Gripal
SISREG: Sistema de Regulação
SIVEP-Gripe: Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe
SRAG: Síndrome Respiratória Aguda Grave
SWAB: Haste flexível utilizada para coleta de amostras microbiológicas/virais
TR-AG: Teste Rápido de Antígeno
UBS / UBSs: Unidade Básica de Saúde
UBSF: Unidade Básica de Saúde da Família
UPA: Unidade de Pronto Atendimento
UTI: Unidade de Terapia Intensiva
UUE: Unidades de Urgência e Emergência
VSR: Vírus Sincicial Respiratório



LISTA DE QUADROS

Quadro 01. Vacinas priorizadas.....	12
Quadro 02. Níveis de Alerta, Indicadores de Acionamento e Ações do Plano de Contingência das Síndrome Gripal 2026.....	16
Quadro 03. Equipe que compõe a Sala de Situação.....	23



LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 01 - Distribuição dos vírus respiratórios por ano 2019-2026.....	9
Gráfico 02 - Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) internados em hospitais de Joinville por Semana Epidemiológica (SE) 2019-2026.....	10
Gráfico 03 - Óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) segundo classificação final - Joinville, 2019-2025.....	11



1. INTRODUÇÃO

Os vírus respiratórios constituem os agentes etiológicos mais comuns responsáveis por doenças em seres humanos, gerando um impacto significativo na morbidade e mortalidade global. Várias famílias desses vírus estão altamente adaptadas para a transmissão eficiente de pessoa para pessoa, circulando mundialmente. Entre os vírus respiratórios mais frequentes, encontram-se o influenza, o vírus sincicial respiratório (VSR), os vírus parainfluenza, o metapneumovírus, os rinovírus, os coronavírus e os adenovírus, que atuam como agentes endêmicos, epidêmicos ou até pandêmicos em todos os continentes.

A sazonalidade dos vírus respiratórios está intimamente relacionada às variações climáticas, que definem um padrão frequente e esperado de aumento ou diminuição da incidência de infecções virais respiratórias ao longo do ano. Desta forma, em áreas de alta densidade populacional, em que a aglomeração de pessoas proporcionam o contato mais próximo, medidas de prevenção são importantes, como uso de máscara em pessoas sintomáticas, etiqueta da tosse e principalmente a imunização, diminuindo assim, a vulnerabilidade da população a surtos sazonais.

Sendo assim, durante o outono e inverno, observa-se um aumento na incidência de infecções respiratórias provocadas pelos vírus respiratórios. Essa situação contribui para uma maior demanda nos serviços de saúde, refletindo no aumento das internações hospitalares, inclusive em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), especialmente entre os grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com condições clínicas preexistentes.

É fundamental, portanto, a correta identificação da Síndrome Gripal (SG), que se caracteriza por uma infecção respiratória com início súbito e/ou da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que representa uma condição clínica de grande importância para a saúde pública, devido à sua gravidade, potencial de transmissão e impacto sobre os serviços de saúde.

Portanto, a vigilância e monitoramento das SG e SRAG são imprescindíveis, pois visam reduzir a morbimortalidade, possibilitando ações de prevenção e controle que antecedem a sazonalidade da doença, colaborando para evitar casos graves e óbitos. Deste modo, o Plano de Contingência de Joinville para SG e SRAG é uma ferramenta essencial para orientar as ações e o manejo dessas doenças respiratórias no Município,



direcionando os profissionais de saúde para um fluxo organizado dentro da rede de atendimento.

2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

2.1. DEFINIÇÃO DE CASO

➤ **Síndrome Gripal (SG)**

Indivíduo com febre (mesmo que referida), acompanhada de tosse ou dor de garganta e com início dos sintomas nos últimos sete dias.

➤ **Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)**

Indivíduo com SG que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão ou dor persistente no tórax OU saturação de oxigênio (O₂) menor que 94% em ar ambiente OU coloração azulada (cianose) dos lábios ou rosto.

Para efeito de notificação no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) devem ser considerados os casos de SRAG hospitalizados ou os óbitos por SRAG independentemente de hospitalização.

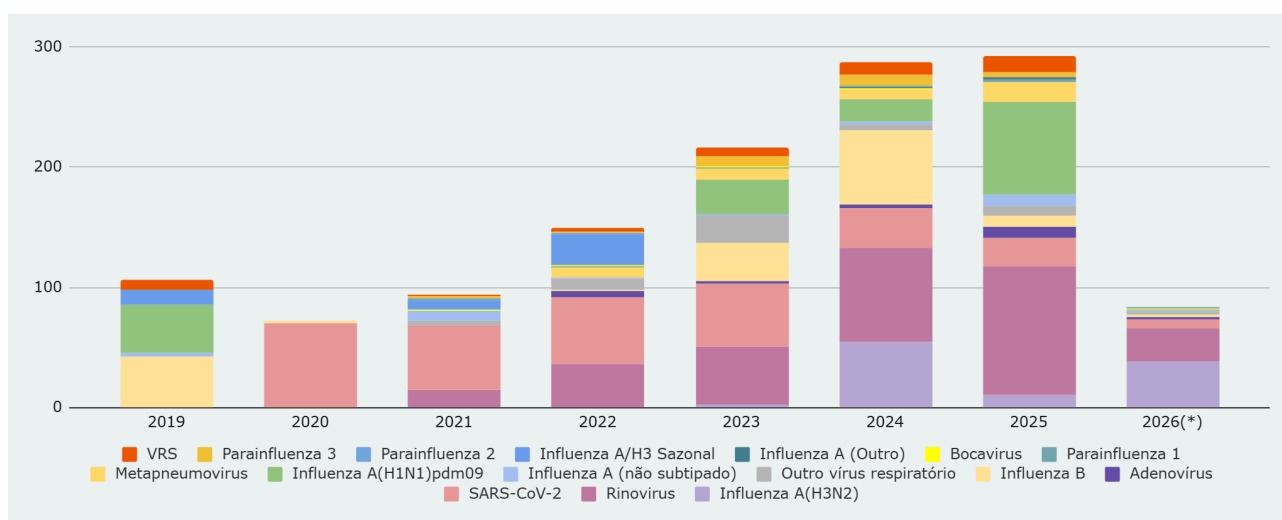
Diante disso, a SRAG é de relevância epidemiológica e está sujeita à notificação compulsória, devendo ser investigada e monitorada. O monitoramento é feito por meio da Vigilância Sentinela, que é uma estratégia que identifica por meio de amostragem os principais vírus circulantes na população em um determinado território. É composta por uma rede de unidades de saúde estrategicamente distribuídas em todas as regiões geográficas do território nacional, além de identificar os vírus circulantes, monitora a tendência de demanda por atendimentos ambulatoriais relacionados à SG.

Essa vigilância permite a detecção oportuna de alterações no padrão epidemiológico antes da ocorrência de casos graves que exigem hospitalização. A coleta de dados é realizada por meio de instrumentos padronizados e as informações são sistematicamente inseridas no SIVEP-Gripe.

O Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina (Lacen/SC) disponibiliza, desde de 2023, a análise das amostras com a execução do painel viral de detecção de 07 (sete) vírus respiratórios. Este painel abrange a identificação de SARS-CoV-2, influenza A e B, VSR, metapneumovírus, adenovírus e rinovírus, auxiliando no monitoramento da circulação de vírus respiratórios relevantes para a saúde pública catarinense.

Em Joinville, a Vigilância Sentinela é implementada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste, onde são coletadas de 10 (dez) a 20 (vinte) amostras semanais de usuários sintomáticos, que são encaminhadas para o Lacen/SC, para a realização da análise do painel viral. A distribuição de vírus identificados nas amostras coletadas em Joinville seguem abaixo, e a atualização de 2026 pode ser acompanhada pelo link: [Painel Síndrome Gripal](#).

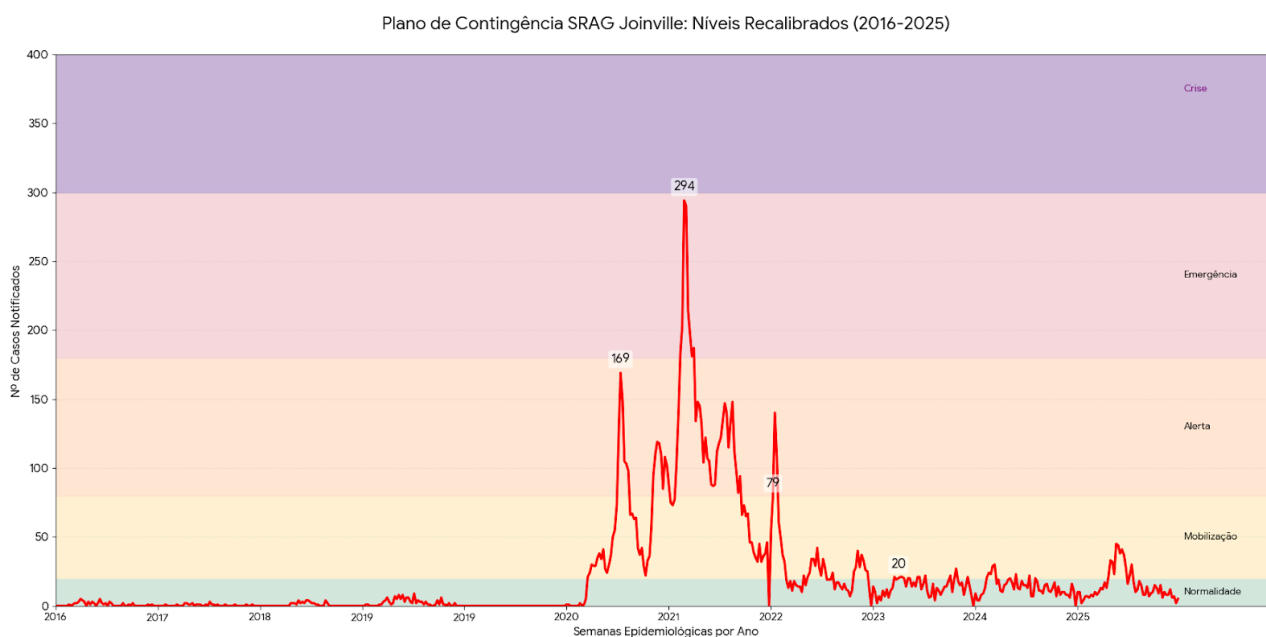
Gráfico 01 - Distribuição dos vírus respiratórios por ano 2019-2026



Fonte: SIVEP-Gripe. (*) *Dados parciais referente à 2026.*

O gráfico 01 mostra a distribuição dos vírus respiratórios identificados de 2019 a 2026 na Unidade Sentinela (UPA Leste). Os dados do ano de 2026 (parcial), até a semana epidemiológica (SE) 13 (29/03 à 04/04), apresentam 114 amostras coletadas e 75% de positividade para vírus respiratórios, com predominância de circulação até o momento dos vírus Influenza A(H3N2) e o Rinovírus.

Gráfico 02 - Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) internados em hospitais de Joinville por Semana Epidemiológica (SE) 2019-2026



Fonte: SIVEP-Gripe.

(*) Inclui usuários internados em Joinville residentes em qualquer município.

(**) Dados parciais referente à 2026.

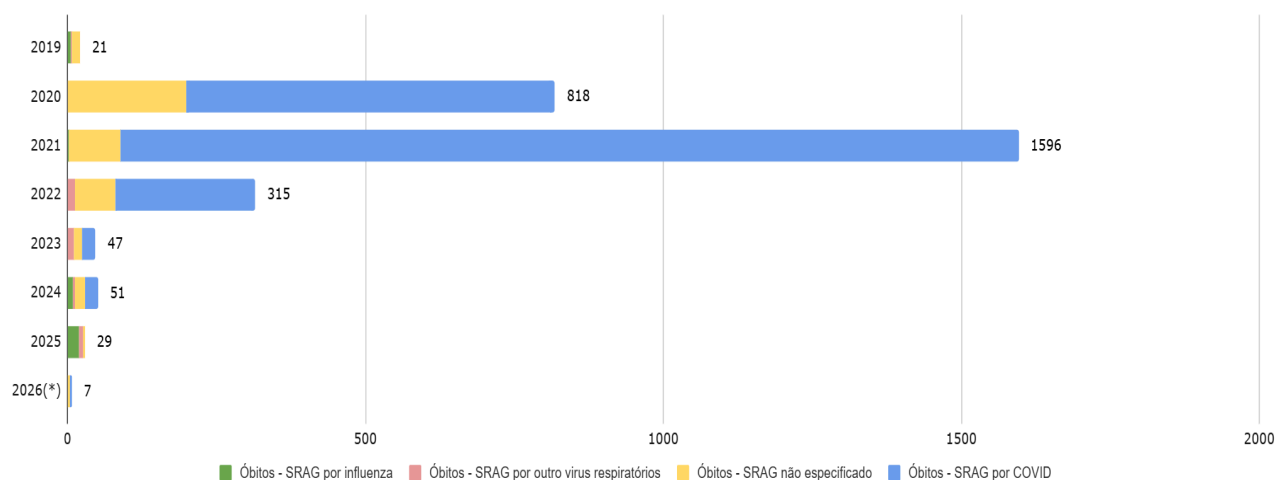
No gráfico 02 observa-se o número de casos de SRAG internados em hospitais de Joinville entre 2019 e 2026 por SE. O monitoramento das internações por SRAG em Joinville (2019-2026), que inclui residentes e não residentes devido ao impacto na disponibilidade de leitos.



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE

Gráfico 03 - Óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) segundo classificação final - Joinville, 2019-2025



Fonte: SIVEP-Gripe.

(*) Residentes em Joinville internados em qualquer outro município.

(**) Dados parciais referente à 2026.

O gráfico 03 mostra os óbitos por SRAG em relação a classificação final, ou seja, pelo seu agente etiológico (influenza, por Covid não especificado e por outros vírus respiratórios - não verificados pelo painel viral utilizado atualmente).

No período pré-pandemia em 2019, Joinville registrou 21 óbitos por SRAG entre residentes. Com a emergência de saúde pública em 2020, houve um salto para 818 mortes, atingindo o pico da série histórica em 2021 com 1.596 óbitos, em sua grande maioria atribuídos à Covid-19. A partir de 2022, o avanço da vacinação resultou em uma redução acentuada na mortalidade, caindo para 315 óbitos naquele ano e para 47 em 2023.

Em 2024, observou-se uma maior diversidade de agentes etiológicos; dos 52 óbitos registrados, 22 foram por Covid-19, 9 por Influenza e os demais distribuídos entre SRAG não especificada e outros vírus. Embora esse número seja significativamente menor que o período pandêmico, ele ainda representa mais que o dobro do registrado no período pré-pandemia. Em 2025, a tendência de óbitos acima do patamar de 2019 persistiu, totalizando 46 casos, um dado alarmante desse ano foi a inversão da causa principal: a Influenza tornou-se o agente predominante com 20 óbitos, enquanto a Covid-19 foi responsável por 3 mortes.

O aumento sustentado dos óbitos por SRAG no cenário pós-pandemia, quando

comparado ao período pré-pandêmico de 2019, exige vigilância intensificada. Este plano de contingência atua como ferramenta estratégica para fortalecer a resposta dos serviços de saúde, aprimorar a detecção precoce e garantir o monitoramento contínuo dos casos. Ao orientar ações coordenadas de prevenção e controle, o documento busca minimizar impactos na saúde da população e assegurar eficiência técnica diante da sazonalidade e de novos surtos. Em 2026 pode-se ver a atualização no painel de Síndrome Gripal citado acima.

Após todas as análises, considera-se a vacinação da população a melhor estratégia para prevenir a pressão assistencial causada pela SRAG, atualmente existem algumas vacinas que devem ser priorizados que são:

Quadro 01. Vacinas priorizadas

Vacina	Proteção	Indicação	Frequência
INFLUENZA	Infecções pelo vírus influenza, doenças respiratórias e complicações como pneumonias.	Crianças (6 meses a <6 anos), gestantes, idosos (60+) e grupos prioritários (saúde, indígenas, etc.).	Anual. Crianças na primeira vez: 2 doses (intervalo de 30 dias). Gestantes: 1 dose a cada gestação.
COVID 19	Formas graves e óbitos por COVID-19 (SARS-CoV-2).	Crianças (6 meses a <5 anos), gestantes, idosos (60+) e grupos prioritários (imunocomprometidos, indígenas, etc.).	Periódica. Idosos e imunocomprometidos: 2 doses (intervalo de 6 meses). Gestantes: 1 dose por gestação. Crianças: esquema básico (2 ou 3 doses) e 1 dose anual para aquelas com comorbidades.
NIRSEVIMABE	Infecção do trato respiratório inferior associada ao Vírus Sincicial Respiratório (VSR).	Bebês prematuros (≤36 semanas e 6 dias) e crianças <24 meses com comorbidades específicas	Dose única por temporada. Prematuros recebem apenas na 1ª sazonalidade. Comorbidades: dose única na 1ª e dose única na 2ª sazonalidade (se a criança permanecer elegível)



VSR	Infecção respiratória inferior em bebês (até 6 meses) via transferência de anticorpos maternos.	Gestantes a partir da 28ª semana de gestação.	Dose única em cada gestação.
------------	---	---	------------------------------

Elaborado: Núcleo de Gestão de Qualidade e Processos (NGQP), 2026.

Para acompanhar a cobertura vacinal do município basta abrir o painel do Ministério da Saúde: [Cobertura Vacinal](#).



3. JUSTIFICATIVA

O Plano de Contingência para o enfrentamento de Síndrome Respiratória segue as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde (MS) e propõe uma estrutura organizacional, definindo as responsabilidades, as estratégias e os recursos necessários para enfrentar situações de emergência devido ao aumento no número de casos das doenças respiratórias no Município. Deste modo, abrange os aspectos essenciais para uma resposta rápida e coordenada, orientando as ações integradas na organização da atenção à saúde, vigilância epidemiológica, controle da transmissão, gestão logística, mobilização social e comunicação.

Diante do aumento da síndrome respiratória, especialmente em períodos sazonais, e da circulação concomitante de diversos vírus com potencial para reinfecções e agravamento clínico, torna-se imprescindível o alinhamento e a integração das ações entre os diversos níveis de atenção e setores envolvidos. Considerando a complexidade e a alta transmissibilidade dos vírus respiratórios, este documento tem como objetivo subsidiar a resposta municipal aos surtos e epidemias de síndrome respiratória, que representam um risco significativo à saúde pública, podendo ocasionar sobrecarga aos serviços de saúde, impactos socioeconômicos e consequências ambientais adversas.

Assim, o presente plano define as responsabilidades operacionais e organizacionais para garantir a integralidade, a efetividade e a continuidade das ações de prevenção, controle e manejo da síndrome respiratória graves no Município de Joinville.

4. ESTRATÉGIAS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

Na aplicação do plano, serão realizadas atividades específicas a serem implementadas em 05 (cinco) níveis de alerta, com indicadores de acionamento para cada nível.



Quadro 02. Níveis de Alerta, Indicadores de Acionamento e Ações do Plano de Contingência da Síndrome Gripal 2026

Normalidade (Verde)
Indicadores de acionamento: Atendimentos de Síndrome Gripal em até 25% dos atendimentos gerais nas UPAs e até 40 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave notificados por semana durante o período sazonal.
<i>Monitoramento de rotina, preparação e vacinação.</i> Ações: Urgência e Emergência • Atender por demanda espontânea conforme classificação de risco nas Unidades de Urgência e Emergência; • Manutenção das coletas de 5 a 10 SWAB na Unidades Sentinela para identificação dos vírus circulantes Atenção Básica • Atender por demanda espontânea usuários com sintomas respiratórios nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs); • Executar plano de ação para ampliação da cobertura vacinal junto do serviço de imunização; • Realizar campanhas educativas sobre vacinação e cuidados com Síndrome Gripal nas escolas através do Programa Saúde na Escola (PSE) Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária, Gestão Estratégica, Diretoria Técnica, Tecnologia da Informação e Comunicação • Organizar processo SEI com todas as informações necessárias; • Atualizar o Plano de Contingência; • Revisar e Publicar Nota Técnica SG e SRAG; • Atualizar o Fluxo de Atendimento de Síndrome Gripal Municipal; • Reforçar Recomendações de Biossegurança nas unidades assistenciais; • Publicizar os dados: Painel SG e SRAG; • Monitoramento das Coberturas Vacinais contra vírus Respiratórios e casos de SRAG e Atendimentos por SRAG. • Monitoramento dos Indicadores de Acionamento dos Níveis do Plano de Contingência. • Sensibilizar os Núcleos Hospitalares de Epidemiologia e os Hospitais privados (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH) para a notificação dos casos de SRAG em tempo oportuno conforme legislação vigente; • Capacitar os profissionais médicos e enfermeiros para o Manejo Clínico e Medidas de Prevenção das SG e SRAG Curso: Síndrome Respiratória Aguda Grave: Preparando Profissionais para o Desafio Respiratório • Envolver o Conselho Municipal de Saúde (CMS) e os Conselhos Locais de Saúde (CLS) na divulgação das informações sobre vacinação e etiqueta respiratória;



- Elaborar e executar um Plano Estratégico de comunicação Interna e externa para orientação e prevenção;
- Atualizar e divulgar fluxos de acesso aos medicamentos oseltamivir e paxlovid;
- Atualizar e publicizar protocolos clínicos, treinamento e outras informações necessárias para o manejo clínico de SG e SRAG;

Administrativa e Financeira

- Identificar e monitorar estoques e contratos necessários para o fornecimento de medicamentos sintomáticos e medicamentos para o tratamento. [Monitoramento Estoque de Medicamentos](#)
- Identificar estoques e contratos necessários para o fornecimento de Insumos e materiais como: Álcool 70%, máscara cirúrgica, máscara N95 (para procedimento) e termômetro digital. [Monitoramento Materiais e Insumos.](#)
- Garantir a disponibilização do Oxigênio Medicinal nas Unidades Básicas de Saúde e Serviço de Urgência e Emergência.

Mobilização (Amarelo)

Indicadores de Acionamento: Atendimentos de Síndrome Gripal maior que 25% dos atendimentos gerais nas UPAs e mais de 40 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave notificados por semana epidemiológica por duas semanas consecutivas.

Ações:

Vigilância em Saúde, Gestão Estratégica, Diretoria Técnica.

- Publicar e divulgar amplamente o Plano de Contingência;
- Publicar Nota de Alerta SG e SRAG;
- Publicar e divulgar o Fluxo de Atendimento de Síndrome Gripal Municipal;
- Fomentar a utilização do Protocolo de Enfermagem;
- Ativar a Sala de Situação ([Anexo 01.](#));
- Visitar as UBSs e UPAs/PA para alinhar e reforçar as informações sobre os fluxos assistenciais;
- Monitoramento das Coberturas Vacinais contra vírus Respiratórios e casos de SRAG e Atendimentos por SRAG.
- Monitoramento dos Indicadores de Acionamento dos Níveis do Plano de Contingência.

Atenção Básica

- Ajustar as agendas médicas e de enfermagem eletivas para aumentar capacidade de atendimento da demanda espontânea;
- Manutenção da vacinação, imunizando o máximo de pessoas possível;
- Prever equipamentos, profissionais, computadores, local e mobiliários necessários para as Unidades de Apoio de atendimento de Usuários com Sintomas Respiratórios.



Urgência e Emergência

- Reforçar com a rede assistencial fluxos de regulação para atenção emergencial;
- Orientar a rede assistencial acerca da inclusão dos casos no SISREG;
- Estudar e monitorar padrão de atendimento (dias e horários de pico) para implementação de mais reforços para atendimento.
- Reforçar a Escala Médica adulto e Infantil nas UPAS e PA.

Área de Contratos e Área Administrativa e Financeira

- Pactuar ampliação de leitos de internação e isolamento no Bethesda, HMSJ e Hospital Infantil e preparar contratos e outros instrumentos legais necessários para resposta rápida a aumento de atendimento das UPAs e internações;
- Pactuar ampliação de leitos de UTI;
- Preparar ampliação de transporte sanitário para casos que agravam e precisam de internação;
- Monitoramento diário de consumo de insumos e medicamentos e organizar possível expansão.

Comunicação

- Aumentar a periodicidade das divulgações para a população cuidados para Evitar Doenças Respiratórias
- Aumentar a periodicidade das divulgações sobre as vacinas que protegem contra Doenças Respiratórias.

Gabinete da SES

- Articular com a Secretária de Gestão de Pessoas a contratação emergencial temporária de equipe para atendimento nas UPAS e Unidades de Apoio;

Alerta (Laranja)

Indicadores de Acionamento: atendimentos de Síndrome Gripal maior que 45% dos atendimentos gerais nas UPAs e mais de 60 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave notificados por semana epidemiológica por duas semanas consecutivas.

Ações:

Atenção Básica

Mobilizar Unidades de saúde para apoio de atendimento das UPAs

Urgência e Emergência

- Ampliar o atendimento médico e de enfermagem segundo perfil de atendimento nas UPAs/ UBSF



Área de Contratos e Área Administrativa e Financeira

- Disponibilizar transporte sanitário com motorista para transferência de pacientes mais graves
- Disponibilizar equipamentos, computadores, local e mobiliários necessários para as Unidades de Apoio de atendimento de usuários com Sintomas Respiratórios.

Vigilância em Saúde

- Monitoramento diário junto dos serviços assistências: das coberturas vacinais contra vírus respiratórios e casos de SRAG e Atendimentos por SRAG.
- Monitoramento diário dos Indicadores de Acionamento dos Níveis do Plano de Contingência.

Comunicação

- Comunicar para a população as Unidades de Apoio para atendimento de Sintomas Respiratórios.
- Intensificar as divulgações para a população sobre os cuidados para Evitar Doenças Respiratórias

Gabinete da SES

- Acionar o gabinete de crise da Prefeitura Municipal de Joinville
- Articular com o estado a reorganização das agendas de cirurgias eletivas para ampliar a quantidade de leitos disponíveis para internação clínica ou UTI

Situação de Emergência Vermelho

Indicadores de Acionamento: Atendimentos de Síndrome Gripal maior que 65% dos atendimentos gerais nas UPAs e mais de 80 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave notificados por semana epidemiológica por duas semanas consecutivas e até 30 óbitos por SRAG na semana, com registro de novo vírus circulando.

Ações:

Atenção Básica

Ampliar o atendimento das Unidades de Apoio

Área de Contratos e Área Administrativa e Financeira

- Acionar serviço Complementar para ampliar leitos de internação
- Acionar leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no HMSJ;

Vigilância em Saúde

- Monitoramento diário junto dos serviços assistências: das coberturas vacinais contra vírus respiratórios e casos de SRAG e Atendimentos por SRAG.



- Monitoramento diário dos Indicadores de Acionamento dos Níveis do Plano de Contingência.
- Boletim informativo diário do número de casos de SRAG e ocupação de leitos.

Comunicação

- Comunicar para a população a ampliação de horário das Unidades de Apoio para atendimento de Sintomas Respiratórios.
- Intensificar as divulgações para a população sobre os cuidados para Evitar Doenças Respiratórias

Gabinete da SES e Demais Secretárias da Prefeitura

- Manter o gabinete de crise da Prefeitura Municipal de Joinville

Crise (Roxo)

Indicadores de Acionamento: Atendimentos de Síndrome Gripal maior que 75% dos atendimentos gerais nas UPAs e mais de 150 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave notificados por semana epidemiológica por duas semanas consecutivas com mais de 30 óbitos por SRAG com esgotamento de recursos na esfera pública municipal.

Ações:

- Hospital de Campanha
- Reorganização de serviços eletivos para dar prioridade ao atendimento de usuários com síndrome gripal;
- Acionamento da esfera estadual e federal.



5. CONCLUSÕES

O monitoramento contínuo e a avaliação das tendências dos casos de SG e SRAG serão realizados de forma integrada pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica, Gerências dos Serviços Assistenciais e Gerência de Planejamento Estratégico.

A análise conjunta permitirá uma avaliação mais abrangente da situação epidemiológica e da capacidade instalada da rede de saúde, subsidiando a tomada de decisão e o direcionamento oportuno das ações.

Caso haja necessidade de declaração de situação de emergência em saúde pública para solicitação de recursos financeiros junto ao Ministério da Saúde, esta será realizada conforme avaliação da situação epidemiológica e da capacidade instalada dos serviços, em conformidade com a [Portaria GM/MS nº 10.484](#), de 27 de março de 2026.

A desativação do plano de contingência ocorrerá quando houver tendência de queda mantida por 4 (quatro) semanas



REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Emergências em Saúde Pública. **Guia para Elaboração de Planos de Contingência.** Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/emergencia-em-sau-de-publica/guia-para-elaboracao-de-planos-de-contingencia>. Acesso em: 12 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento do Programa Nacional de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis. **Guia de Manejo e Tratamento de Influenza 2023.** Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/influenza/guia-de-manejo-e-tratamento-de-influenza-2023>. Acesso em: 12 jun. 2025.

PERNAMBUCO. Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. **Plano de Contingência das Doenças Respiratórias Sazonais na Infância:** docx - FINAL FEV 18.pdf. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1VTmXIQjw0YiU-R0FyrqOej1SkX8EoA9I/view>. Acesso em: 10 jun. 2025.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Superintendência de Vigilância em Saúde. Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Gerência de Doenças Infecciosas Agudas e Imunização (GEDIM). **Boletim da Síndrome Respiratória:** COVID-19, Influenza e Outros Vírus Respiratórios (OVR). Semana Epidemiológica 01 até 16 (dados até 19 de abril de 2025). Florianópolis, 2025. Disponível em: [https://dive.sc.gov.br/phocadownload/doencas-agrivos/Gripe%20\(Influenza\)/Boletins/boletim-sindrome-respiratoria-08-2025.pdf](https://dive.sc.gov.br/phocadownload/doencas-agrivos/Gripe%20(Influenza)/Boletins/boletim-sindrome-respiratoria-08-2025.pdf). Acesso em: 10 jun. 2025.

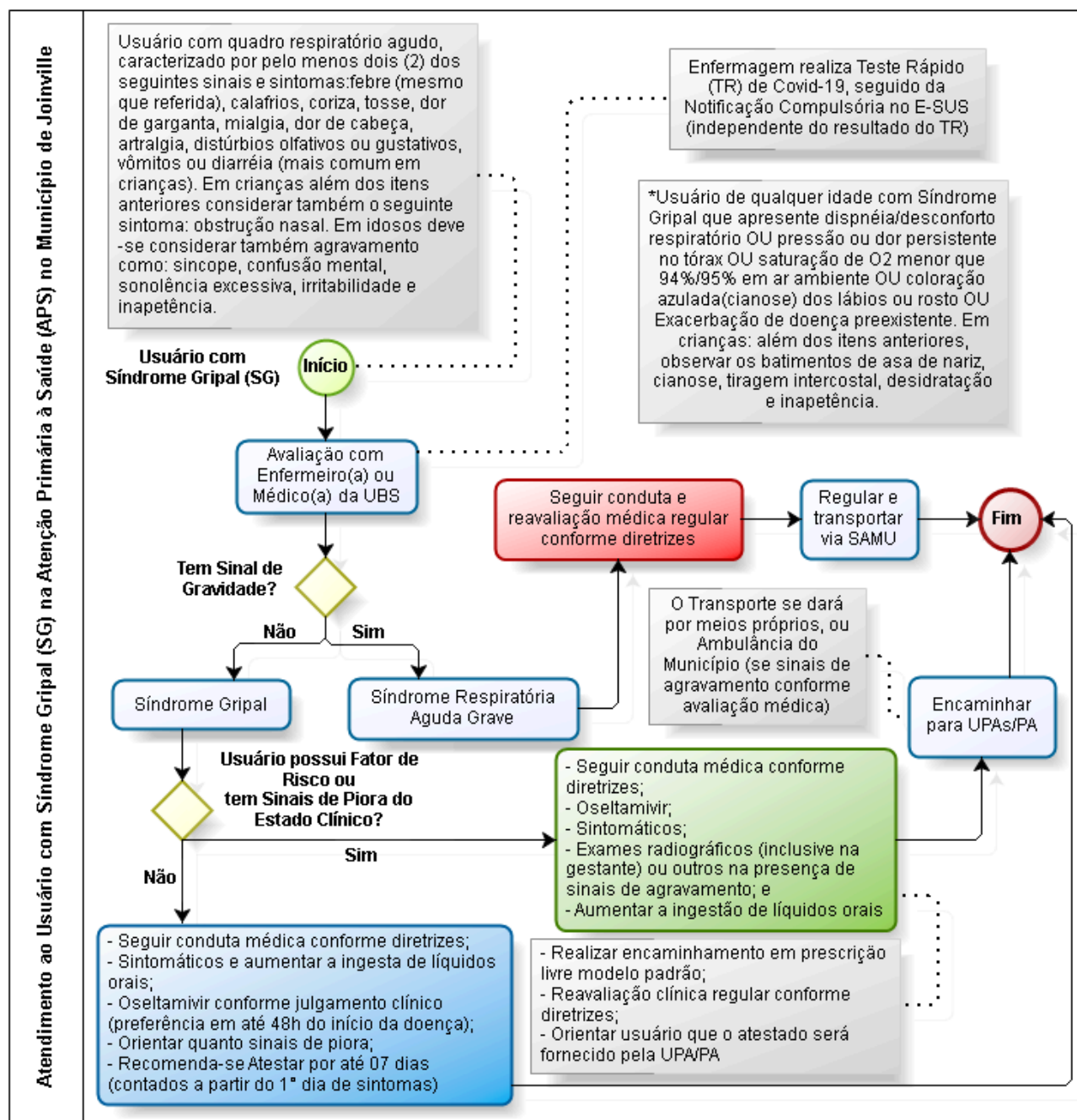


Quadro 03. Equipe que compõe a Sala de Situação

ÁREA	RESPONSÁVEL
Diretoria Executiva da SES	→ Diretoria de Vigilâncias → Diretoria Técnica → Diretoria de Atenção Primária À Saúde → Diretoria de Média e Alta Complexidade → Diretoria de Serviços Complementares de Saúde → Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira → Diretoria de Gestão Estratégica
Vigilância em Saúde	→ Gerente de Vigilância em Saúde → Coordenação de Vigilância Epidemiológica → Técnico da Vigilância Epidemiológica
Vigilância Sanitária	→ Gerente de Vigilância Sanitária
Atenção Primária à Saúde	→ Gerentes de Distrito Sanitário
Urgência e Emergência	→ Gerente de Urgência e Emergência
Gestão Estratégica e Planejamento	→ Gerente de Planejamento Estratégico
Qualidade e Desenvolvimento Institucional	→ Gerente de Qualidade e Desenvolvimento Institucional
Administrativa	→ Gerente de Gestão Administrativa → Gerente de Insumos Materiais e Equipamentos
Tecnologia da Informação	→ Gerente de Tecnologia da Informação
Laboratório e Farmácia	→ Gerente de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal
Contratos e Convênios	→ Gerente de Contratos e Convênios

Fonte: SES, 2026.

Fluxograma 01. “Atendimento ao Usuário com Síndrome Gripal (SG) na Atenção Primária à Saúde (APS) no Município de Joinville”



Fonte: NGQP, 2026.



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE

Informações referentes ao **Fluxograma 01** “Atendimento ao Usuário com Síndrome Gripal (SG) na Atenção Primária à Saúde (APS) no Município de Joinville”.

Importante:

Em casos confirmados de COVID-19 (por TR-AG ou exame de biologia molecular), em adultos com alto risco para evolução para doença grave, está indicada a prescrição da associação dos fármacos antivirais nirmatrelvir e ritonavir (NMV/r) até 5 dias após o início dos sintomas. O grupo de risco é caracterizado por pacientes com sintomas leves e moderados (não graves) e que não requerem oxigênio suplementar, independentemente da condição vacinal, sendo estes imunocomprometidos com idade 18 anos e pessoas com idade 65 anos. Em relação à posologia, cada dose do tratamento contém 2 comprimidos de 150 miligramas (mg) de nirmatrelvir (total de 300 mg) e 1 comprimido de 100 mg de ritonavir, que devem ser tomados simultaneamente. Essa dosagem deve ser administrada, na maior parte dos pacientes, 2 vezes ao dia, por um período de 5 dias. (Brasil, 2024).

[Guia - Diretrizes para o enfrentamento da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios de importância em saúde pública.](#)

Fatores de risco: população indígena; gestantes; puérperas (até duas semanas após o parto); crianças < 5 anos (sendo que o maior risco de hospitalização é em menores de 2 anos, especialmente as menores de 6 meses, que possuem maior taxa de mortalidade); adultos (até 60 anos); pneumopatias (incluindo asma); cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica); doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme); distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus); transtornos neurológicos e do desenvolvimento que possam comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção congênita, lesões medulares, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, AVC ou doenças neuromusculares); imunossupressão (medicamentos, neoplasias, HIV/aids); nefropatias e hepatopatias; obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal – IMC 40 em adultos); pacientes com tuberculose de todas as formas.

***** Sinais de piora do estado clínico:** persistência ou agravamento da febre por mais de três dias; aparecimento de dispneia ou taquipneia ou hipoxemia; hipotensão arterial; ausência de diurese nas últimas 06 horas ou após hidratação; alteração do sensorio; desidratação e, em crianças exacerbação dos sintomas gastrointestinais.

******Solicitação de Ambulância do Município:** disponível no processo SEI Nº 24.0.226345-2.

Guia de Manejo e Tratamento de Influenza 2023 -

<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/influenza/guia-de-manejo-e-tratamento-de-influenza-2023/view>

Manual de Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV) -

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vacinacao-imunizacao-pni/manual_eventos-adversos-pos-vacinacao_4ed_atualizada.pdf/view

Guia NMV/r para Covid-19 -

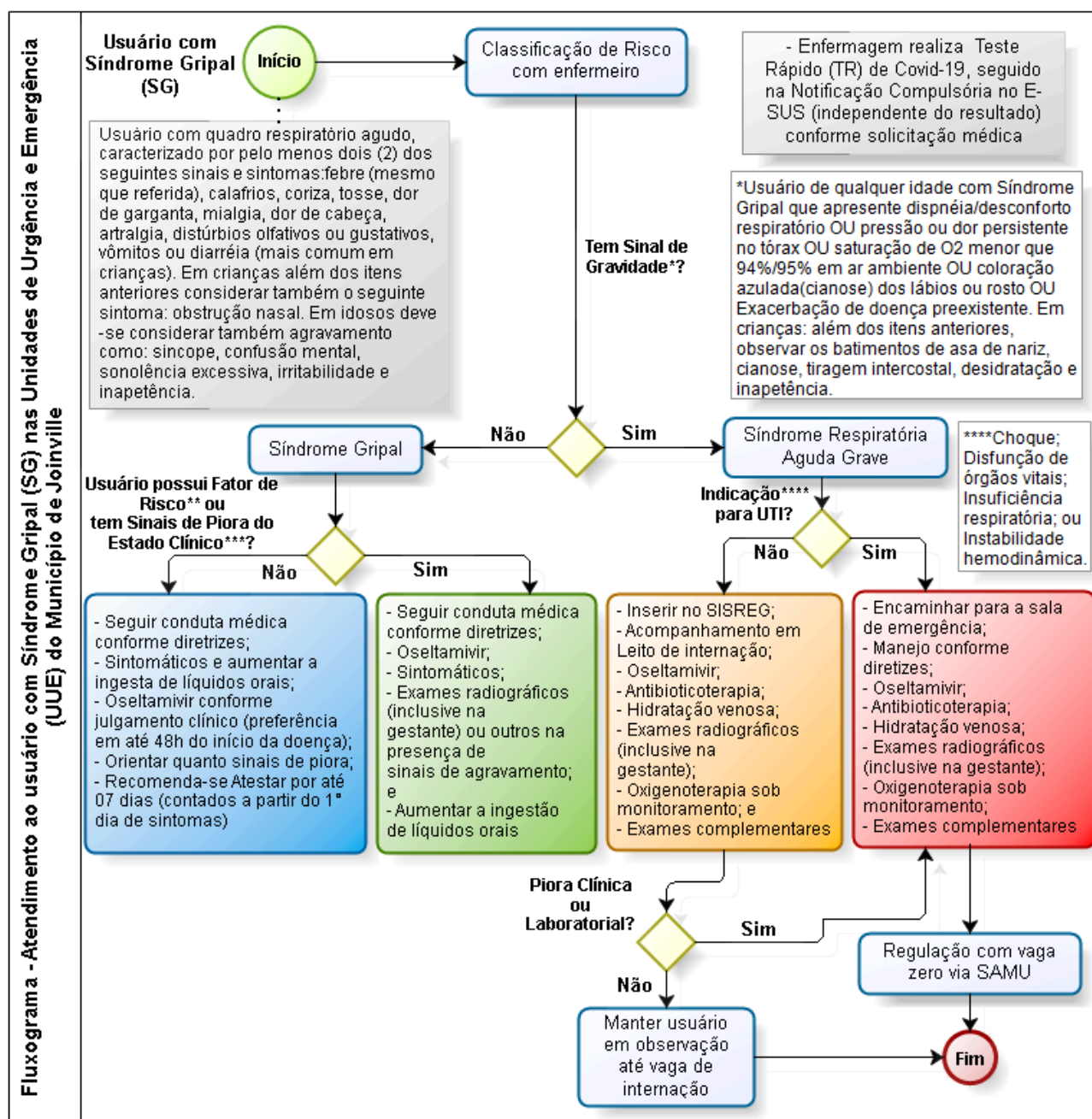
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_uso_nirmatrelvir_ritonavir_covid19.pdf

Profilaxia VSR (Palivizumabe) -

https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/daf/publicacoes/anticorpo_palivizumabe_sazonalidade_virus_vsr.pdf/view



Fluxograma 02. “Atendimento ao usuário com Síndrome Gripal (SG) nas Unidades de Urgência e Emergência (UUE) do Município de Joinville”



Fonte: NGQP, 2026



Informações referentes ao **Fluxograma 02**. “Atendimento ao usuário com Síndrome Gripal (SG) nas Unidades de Urgência e Emergência (UUE) do Município de Joinville”

Importante:

Em casos confirmados de **COVID-19** (por TR-AG ou exame de biologia molecular), em adultos com alto risco para evolução para doença grave, está indicada a prescrição da associação dos fármacos antivirais **nirmatrelvir e ritonavir (NMV/r)** até 5 dias após o início dos sintomas. O grupo de risco é caracterizado por pacientes com sintomas leves e moderados (não graves) e que não requerem oxigênio suplementar, independentemente da condição vacinal, sendo estes imunocomprometidos com idade ≥ 18 anos ou pessoas com idade ≥ 65 anos. Em relação à posologia, cada dose do tratamento contém 2 comprimidos de 150 miligramas (mg) de nirmatrelvir (total de 300 mg) e 1 comprimido de 100 mg de ritonavir, que devem ser tomados simultaneamente. Essa dosagem deve ser administrada, na maior parte dos pacientes, 2 vezes ao dia, por um período de 5 dias. (Brasil, 2024)

[Guia - Diretrizes para o enfrentamento da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios de importância em saúde pública.](#)

Fatores de risco: população indígena; gestantes; puérperas (até duas semanas após o parto); crianças **< 5 anos** (sendo que o maior risco de hospitalização é em menores de 2 anos, especialmente as menores de 6 meses, que possuem maior taxa de mortalidade); adultos (≥ 60 anos); pneumopatias (incluindo asma); cardiopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica); doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme); distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus); transtornos neurológicos e do desenvolvimento que possam comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção congênita, lesões medulares, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, AVC ou doenças neuromusculares); imunossupressão (medicamentos, neoplasias, HIV/aids); nefropatias e hepatopatias; obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal - IMC ≥ 40 em adultos); pacientes com tuberculose de todas as formas.

***** Sinais de piora do estado clínico:** persistência ou agravamento da febre por mais de três dias; aparecimento de dispneia ou taquipneia ou hipoxemia; hipotensão arterial; ausência de diurese nas últimas 06 horas ou após hidratação; alteração do sensorio; desidratação e, em crianças exacerbação dos sintomas gastrointestinais.

Guia de Manejo e Tratamento de Influenza 2023 -

<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/influenza/guia-de-manejo-e-tratamento-de-influenza-2023/view>

Manual de Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV) -

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vacinacao-imunizacao-pni/manual_eventos_adversos_pos_vacinacao_4ed_atualizada.pdf/view

Guia NMV/r para Covid-19 -

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_uso_nirmatrelvir_ritonavir_covid19.pdf

Profilaxia VSR (Palivizumabe) -

https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/daf/publicacoes/anticorpo_palivizumabe_sazonalidade_virus_vsr.pdf/view



Anexo 01. Infográfico “Cuidados para Evitar Doenças Respiratórias”

Fonte: SECOM, 2025.